

AVALUACIÓ PSICOLÓGICA

Cuestionario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2

Juan Antonio Amador Campos

Maria Forns Santacana

Teresa Kirchner Nebot

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona

Nombre original: *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2* (Cuestionario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2)

Autores: S.R. Hathaway y J.C.McKinley, 1940 (original)

Adaptación española: A. Ávila y F. Jiménez, 1999

Administración: Individual y colectiva

Aplicación: Adultos (19-65 años)

Duración: Variable, de 60 a 90 minutos

Utilidad: Evaluación de diferentes aspectos de la personalidad. Presenta tres grupos de escalas: básicas, de contenido y suplementarias. Además, hay un grupo de escalas de validez y otro de escalas adicionales.

Nivel de lectura: equivalente a 2º de ESO.

Fundamentos (MMPI)

1. Aplicación práctica a los problemas clínicos que requirieran evaluación de la personalidad
2. Frases enunciativas como el mejor medio de obtener información del sujeto o allegados.
3. Contribuir al diagnóstico
4. Eficaz y de poco coste
5. Puntuaciones simples
6. Medir variables comunes en la práctica psiquiátrica
7. Aportar una medida de la colaboración del sujeto

Construcción de la prueba (MMPI)

1. Reunión de un gran número de enunciados, razonablemente independientes entre sí
2. Formación de grupos criterio: pacientes psiquiátricos que presentaban de una forma bastante pura: trastorno hipocondríaco, reacción depresiva, histeria de conversión, desviación psicopática, paranoia, psicastenia, esquizofrenia e hipomanía.
3. Utilización de un grupo contraste o criterio: familiares de los pacientes
4. Administración de los ítems a los grupos normales y clínicos. Identificación de los ítems que diferenciaban ambos grupos e inclusión en la escala correspondiente

Revisión del MMPI, objetivos:

1. Revisar y modernizar la redacción de los items; eliminar los obsoletos y reemplazarlos por otros más adaptados a los problemas y situaciones actuales.
2. Asegurar la continuidad con las escalas clínicas y algunas suplementarias del MMPI original.
3. Desarrollar nuevas escalas que evaluaran problemas que no se podían analizar con el MMPI original.
4. Elaborar baremos apropiados para adultos y adolescentes (MMPI-A)
5. Recoger un conjunto amplio de datos clínicos que permitieran evaluar los cambios de las escalas originales y validar las nuevas escalas.

Escalas

- Validez
- Clínicas
- Contenido
- Suplementarias

Escalas

Validez:

- ? (Interrogante)
- L (Mentira)
- F (Incoherencia)
- K (Factor corrector)
- F_b posterior
- TRIN (Inconsistencia de respuestas verdadero)
- VRIN (Inconsistencia de respuestas variable)

Clínicas

1. Hipocondría: Hs
2. Depresión: D
3. Histeria de conversión: Hy
4. Desviación psicopática: Pd
5. Masculinidad-feminidad: Mf
6. Paranoia: Pa
7. Psicastenia: Pt
8. Esquizofrenia: Sc
9. Hipomanía: Ma
0. Introversión social: Si

Contenido

1. Ansiedad: ANX
2. Miedos: FRS
3. Obsesividad: OBS
4. Depresión: DEP
5. Preocupaciones por la salud: HEA
6. Pensamiento extravagante: BIZ
7. Hostilidad: ANG
8. Cinismo: CYN
9. Conductas antisociales: ASP
10. Comportamiento tipo A: TPA
11. Baja autoestima: LSE
12. Malestar social: SOD
13. Problemas familiares: FAM
14. Interferencia laboral: WRK
15. Indicadores negativos de tratamiento: TRT

ESCALAS DE VALIDEZ

? (Interrogante). Elementos no contestados. Puntuaciones directas de más de 30 invalidan el perfil

P. D.	Perfil	Posibles implicaciones
≥30	Probablemente inválido	Problemas de lectura graves Confusión Indecisión Desafío
10-29	Validez cuestionable	Problemas de lectura leves Muy cauteloso
<10	Válido	

L (Mentira). Items que tratan de defectos y debilidades menores que la mayoría de las personas están dispuestos a admitir. Intentos deliberados de presentarse "bajo el mejor ángulo"

P. T.	Perfil	Posibles implicaciones
≥80	Probablemente inválido	Fingir un buen ajuste
70-79	Validez cuestionable	Respuestas al azar, rechazo de faltas, presenta una visión “muy favorable” de su ajuste.
60-69	Probablemente válido	Moralista, rígido, convencional
50-60	Válido	Conforme con su imagen
<50	Actitud de “mala imagen”	Crítico, independiente, sarcástico

F (Incoherencia). Identificación de formas desviadas o atípicas de responder a la prueba

P. T.	Perfil	Posibles implicaciones
≥100	Inválido	Actitud no cooperativa (Respuestas al azar) Fingir una mala imagen Persona desorientada, confusa, con conductas psicóticas
80-100	Validez cuestionable	Exagerar los problemas (fingir una enfermedad) Estado confusional

65-79	Probablemente válido	Fingir encontrarse mal Propensión a los cambios de humor, desasosegado, inquieto Problemas de sociabilidad
<64	Válido	

K (factor corrector). Mide intentos de negar o exagerar la patología. Los items hacen referencia a características que muchas personas prefieren negar que las tienen ellos o su familia, mientras que otros las encuentran inofensivas.

- Puntuaciones elevadas están asociadas a niveles socioeconómicos y culturales altos

P. T.	Perfil	Posibles implicaciones
> 70	Inválido	Muy defensivo, desconfianza Fingir buena imagen Inhibición, timidez
60-70	Validez cuestionable	Negación de los problemas, algo defensivo Intolerante Poco intuitivo
50-59	Válido	
<50	Inválido	Apertura y franqueza. Resalta sus dificultades, se finge enfermo Confuso, autocrítico, suspicaz, cínico, introvertido, conformista.

F_b posterior

Se desarrolló igual que la escala F original, recogiendo los items que presentaban una frecuencia de respuesta muy baja en una determinada dirección (< 10% de sujetos).

Formada por 40 items que aparecen después de los de la escala F (después del 370), por lo que permite identificar los protocolos en los que el sujeto ha dejado de prestar atención a los items y a cambiado a un patrón de respuestas al azar.

Puede considerarse una prueba de la validez del protocolo, sobre todo para las escalas de contenido y suplementarias.

Puntuaciones altas puede indicar que se ha respondido al azar o todo falso, que se intenta ofrecer una mala imagen de sí mismo, exagerar los problemas, confusión, problemas psicopatológicos, fatiga o cansancio.

TRIN (Inconsistencia de respuestas verdadero) y VRIN (Inconsistencia de respuestas variable).

Evalúan la tendencia del sujeto a responder de forma inconsistente o contradictoria. Están formadas por pares de items de contenido similar u opuesto (VRIN) o de pares de contenido opuesto (TRIN).

Puntuación VRIN: Número de pares de items a los que se responde de forma inconsistente. Puntuación alta (≥ 14) indica que el sujeto ha respondido al azar.

Puntuación TRIN: Si el sujeto responde Verdadero a los dos items del par, +1 ; si responde falso -1. Puntuaciones altas (≥ 14) indican tendencia a la aquiescencia en las respuestas; puntuaciones bajas (< 9) tendencia a la no aquiescencia o contestar falso de manera indiscriminada.

ESCALAS CLÍNICAS

- 1. Hipocondría (Hs).** Preocupaciones excesivas por la salud, quejas somáticas, con escasa base orgánica.

Punt. T	Posibles hipótesis
> 80	Múltiples síntomas y quejas somáticas vagas e indefinidas
60 – 80	Preocupaciones somáticas; quejas múltiples Poca tolerancia a cualquier problema físico Trastornos del sueño Falta de energía Exigente, insatisfecha, poco feliz
40 - 59	Puntuaciones medias Pequeñas o ninguna preocupación por la salud Equilibrado, realista, perspicaz, optimista

- 2. Depresión (D).** Los ítems reflejan sintomatología depresiva: desánimo, falta de felicidad, de interés, apatía, retardo psicomotor, irritabilidad y tendencia a la preocupación.

Punt. T	Posibles hipótesis
> 70	Depresión clínicamente severa Abatida, lenta en el pensar y actuar Preocupada por la muerte, suicida Culpabilizada, sentimientos de inutilidad e inadecuación Afectada por los problemas, desesperada
60 – 70	Depresión moderada Humor disfórico Insatisfecha con la vida Preocupada, ausencia de energía, dificultad para concentrarse Falta de confianza en sí misma, molesta.
40 - 59	Puntuaciones medias Conforme consigo misma Estable, ajustada, realista

- 3. Histeria de conversión (Hy).** Los elementos reflejan quejas físicas específicas o trastornos molestos, negación de los problemas de la vida, o de la ansiedad social, necesidad de afecto, quejas somáticas e inhibición de la agresión

Punt. T	Posibles hipótesis
> 80	Reacciona a la tensión desarrollando síntomas físicos: dolores de cabeza, fatiga, taquicardia, ... Muy sugestionable Ansiedad frecuente; episodios de crisis de angustia Rabietas infantiles Desinhibida
60 – 80	Síntomas somáticos; trastornos del sueño Falta de comprensión de la causa de los síntomas Inmadura, egocéntrica, exigente, absorbente, cariñosa, sugestionable
40- 59	Puntuaciones medias Realista, lógica, sensata

4. Desviación psicopática (Pd). Los elementos recogen problemas relacionados con las normas sociales y morales del comportamiento: problemas familiares, delincuencia, problemas sexuales y dificultades con la autoridad. También hacen referencia a problemas de rendimiento académico o en el trabajo

Punt. T	Posibles hipótesis
> 75	Comportamiento antisocial Irresponsable, egocéntrica, inmadura, de juicio pobre Agresiva, impulsiva, busca la satisfacción inmediata de los impulsos, actúa sin tener en cuenta las consecuencias de su conducta
60 – 75	Puede tener problemas con la ley y autoridad, con el consumo de drogas (varones) Airada, irritable, no cooperativa (mujeres) Problemas familiares Relaciones superficiales Impulsiva, enérgica, creativa, extrovertida
40 – 59	Puntuaciones medias Sincera, confiada, responsable, persistente

5. Masculinidad-feminidad (Mf). La escala se construyó a partir de los síntomas que presentaban varones que buscaron ayuda psiquiátrica para controlar sus sentimientos homosexuales o para hacer frente a la confusión acerca de su *rol* de género. Los ítems hacen referencia a intereses en el trabajo, aficiones,

pasatiempos, preocupaciones, temores, actividades sociales y preferencias religiosas

Punt. T	Posibles hipótesis
> 75	Posibles conflictos sobre la identidad sexual
60 – 75	Ausencia de intereses masculinos tradicionales (varones) Intereses intelectuales, sensible, curioso, creativo, imaginativo, empático (varones) Rechazo del papel femenino convencional (mujeres) Asertiva, competitiva (mujeres)
40 – 59	Puntuaciones medias Práctico, convencional, realista (varones) Considerada, acomodaticia, empática (mujeres)
< 35	Extremadamente masculino (“macho”), agresivo, rudo, alegre, divertido, prefiere la acción al pensamiento, práctico (Varones) Se describe en términos del estereotipo femenino, pasiva, sumisa, sensible, modesta (Esta descripción tiene poca utilidad para mujeres con formación media o universitaria)

6. Paranoia (Pa). El contenido de los items de esta escala hace referencia a una sensibilidad interpersonal muy acusada y a la tendencia a malinterpretar las intenciones de los demás, junto con ideas de referencia, suspicacia extrema, delirios de persecución o de grandeza.

Punt. T	Posibles hipótesis
> 70	Considerar psicosis paranoide
60 – 70	Excesivamente sensible, suspicaz Airada, resentida, reservada Predisposición paranoide
50 – 59	Sensible, suspicaz Airada, resentida, reservada Ausencia de control emocional
45 – 49	Puntuaciones medias Racional, cauta, flexible

7. Psicastenia (Pt). Los items se refieren a compulsiones (acciones repetitivas) u obsesiones (incapacidad para evitar pensamientos parásitos, repetitivos o ideas obsesivas). También evalúa ansiedad, baja autoestima, dudas acerca de la propia

capacidad o dificultad para tomar decisiones.

Punt. T	Posibles hipótesis
> 75	Ansiedad, tensión y miedo exagerado Rumiaciones Rituales rígidos Fobias supersticiosas Falta de concentración Trastornos del pensamiento
60 – 75	Ansiedad moderada, depresión Falta de seguridad Sueño intranquilo, pesadillas Culpabilidad, perfeccionismo, indecisión
40 – 59	Puntuaciones medias Sincera, adaptada, bien organizada

8. Esquizofrenia (Sc). Pensamiento excéntrico, alteraciones de la percepción, delirios de persecución y alucinaciones. También aislamiento social relaciones familiares deficientes, dificultades para controlar los impulsos, falta de concentración, etc.

Punt. T	Posibles hipótesis
> 75	Posible trastorno esquizofrénico: confusa, desorientada, desorganizada; pensamientos y actitudes poco usuales
60 – 75	Estilo de vida esquizoide: no se siente parte del entorno social, aislada Confusa, miedosa; reservada, no comprometida Fantasía y ensueños excesivos, dificultad para separar la fantasía de la realidad Pesadillas
40 – 59	Puntuaciones medias Adaptada, buen equilibrio

9. Hipomanía (Ma). Humor elevado, habla y actividad motora aceleradas, irritabilidad, descarga de ideas y periodos de depresión leves

Punt. T	Posibles hipótesis
> 80	Posible trastorno bipolar, tipo maníaco

70 – 80	Energía excesiva, ausente de dirección Poco realista en su auto-valoración Impulsiva, muy habladora, mandona Baja tolerancia a la frustración
60 - 69	Activa, enérgica, extrovertida, rebelde, creativa
40 – 59	Puntuaciones medias Sociable y amistosa Responsable, realista, entusiasta, equilibrada
< 40	Escasa energía, nivel de actividad bajo, fatiga crónica, deprimida, ansiosa, falta de confianza en sí misma, tienen dificultades para expresar los sentimientos abiertamente. Práctica, razonable, convencional, modesta, aislada, muy controlada

0. Introversión social (Si). Aislamiento de los demás, falta de participación en actividades sociales y ausencia de conductas asertivas.

Punt. T	Posibles hipótesis
> 75	Extremadamente reservada
60 – 75	Introvertida, reservada, tímida Falta de seguridad Sumisa, condescendiente Formal, responsable en el trabajo, de confianza
40 – 59	Puntuaciones medias Activa, amistosa, equilibrada
< 45	Sociable, extravertida, habladora, activa, enérgica, le gustan las situaciones competitivas, actúa sin considerar las consecuencias de sus acciones

ESCALAS DE CONTENIDO

ESCALA	PUNTUACIONES ALTAS
1. Ansiedad: ANX	Síntomas de ansiedad: tensión, manifestaciones somáticas, insomnio, preocupaciones y falta de concentración Dificultad para tomar decisiones
Miedos: FRS	Muchos miedos específicos: sangre, alturas, animales, desastres, etc
Obsesividad: OBS	Rumiaciones, preocupaciones excesivas, indecisión, conductas compulsivas
Depresión: DEP	Tristeza, anergia, desesperanza y síntomas característicos de depresión
Preocupaciones por la salud: HEA	Muchos síntomas físicos: náuseas, vómitos, problemas de estómago, visión o audición deficientes, síntomas cardiovasculares, problemas dermatológicos, etc
Pensamiento extravagante: BIZ	Pensamientos extraños y peculiares, alucinaciones auditivas, visuales u olfativas. También ideación paranoide
Hostilidad: ANG	Problemas para controlar la ira. Pierden el control con facilidad y actúan de forma agresiva contra otras personas u objetos; irritables, impacientes, exaltados, tercos
Cinismo: CYN	Misantropía, sospechan intenciones ocultas de tipo negativo en los demás (p. ej. creen que los demás actúan correctamente por miedo a ser castigados), desconfiados
Conductas antisociales: ASP	Misantropía y conductas antisociales; si no las ejecutan, las aprueban
Comportamiento tipo A: TPA	Orientados por el trabajo, rápidos, impacientes, se irritan y molestan con facilidad. Directos y autoritarios
Baja autoestima: LSE	Mala opinión de sí mismos, sentimientos negativos: menos hábiles, torpes, patosos
Malestar social: SOD	Intranquilos en situaciones sociales, se aíslan, tímidos se alejan de las fiestas y bullicios

Problemas familiares: FAM	Frecuentes problemas en la relación familiar
Interferencia laboral: WRK	Conductas o actitudes que interfieren en el trabajo (escasa autoconfianza, dificultad para tomar decisiones, presión, ausencia de apoyo familiar o actitudes negativas hacia colegas)
Indicadores negativos de tratamiento: TRT	Actitudes negativas hacia los médicos y el tratamiento de salud mental. Creen que nadie puede atenderles ni ayudarles

ÍNDICES Y PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN

Elevación media del perfil. Es la media aritmética de las puntuaciones T en ocho de las escalas clínicas (Hs, D, Hy, Pd, Pa, Pt, Sc y Ma). Proporciona una información del grado de desajuste que aparece en el MMPI-2. Medias por encima de 65 indican que la persona informó de un gran número de problemas psicológicos.

Índice F – K. Desarrollado por Gough (1950) es una medida de la simulación en las respuestas o de la atribución de un número excesivo de problemas. Gough sugirió que la diferencia entre la puntuación directa de las escalas F y K podía servir como un indicador útil para detectar perfiles de individuos que fingían sentirse mal. Gough (1950) y Meehl (1951) indicaron que cuando este índice es positivo y mayor de 9 se está simulando un desorden (el sujeto finge estar mal) o tiene una percepción excesiva de problemas psicológicos. Carson (1969) señaló que una puntuación de 11 o mayor produce una identificación más precisa.

Siempre que $F > K$ se puede considerar la posibilidad de que se haya “fingido estar mal”; cuanto mayor sea la diferencia, mayor es la probabilidad de que sea así.

Índice de Goldberg. Desarrollado por este autor en 1965, sirve para discriminar entre perfiles neuróticos y psicóticos. Se calcula sumando y restando las puntuaciones T de las siguientes escalas: $L + Pa + Sc - Hy - Pt$. Si el resultado > 45 , sugiere un perfil psicótico.

Las descripciones de las escalas de validez, clínicas, de contenido y de los índices se han elaborado a partir de las siguientes fuentes:

Butcher, J. N. (1995). Interpretation of the MMPI-2. En L. E. Beutler y M. R. Berren (Eds.), *Integrative Assessment of Adult Personality* (pp. 206-239). Nueva York: Guilford Press.

Graham, J. R. (1987). *MMPI: Guía práctica*. México: El Manual Moderno

Graham, J. R. (1990). *MMPI-2: Assessing personality and psychopathology*. Nueva York: Oxford University Press.

Hathaway, S. R. Y McKinley, J. C. (1999). *MMPI-2. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2*. Madrid: TEA.